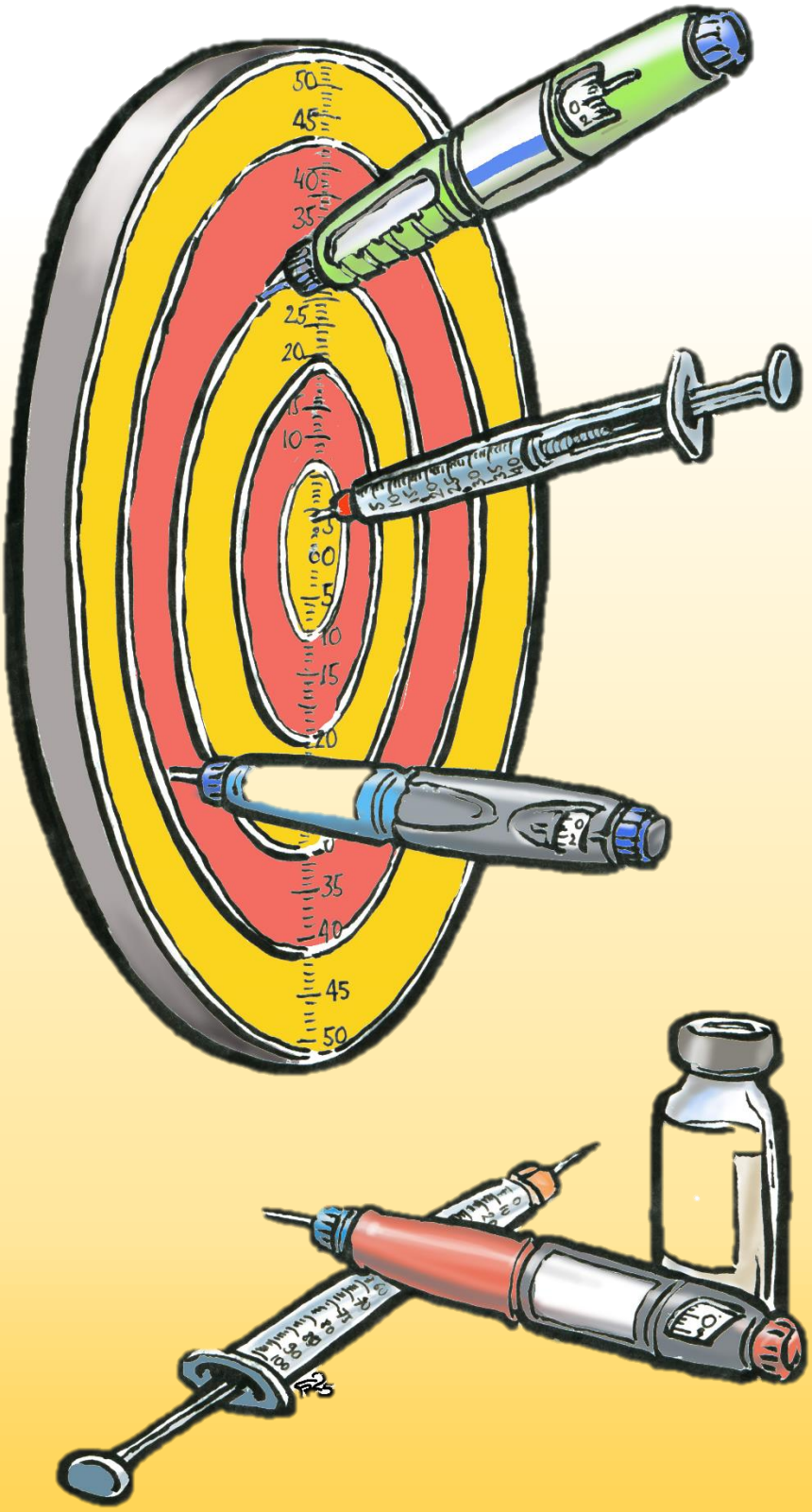
phel infos 89

Bulletin d'information
de la Pharmacie des Hôpitaux de l'Est Lémanique

Mai 2025



SOMMAIRE

► NOUVEAUTES SUR LA LISTE DES MEDICAMENTS p.3

Ajout / Remplacement sur la liste PHEL		
Analgésique	Morphine sulfate 1 mg/ml, Médicassette 100 ml	p.5
Antibiotique	Cefuroxim Fresenius® remplace Cefuroxim Labatec® 750 mg et 1.5 g, poudre pour solution injectable	p.6
	Amoxicillin OrPha® remplace Delamoxyl® 500 mg et 1 g, poudre pour solution injectable	p.6
Anticoagulant	Rivaroxaban Sandoz® remplace Xarelto® 10 mg, 15 mg et 20 mg, comprimé	p.6
	Heparine Bichsel® remplace Heparine Sintetica® 20'000 UI/48 ml	p.6
Antidépresseur	Sertraline® Sandoz 100 mg, comprimé	p.5
Antidote	SMOFlipid® 20 % remplace Lipofundin MCT LCT® 20 % 250 ml, solution injectable	p.6
Antidote et électrolyte	Calcium gluconate 10 % remplace Calcium gluBIOnate 90 mg/10 ml	p.6
Insuline	Toujeo® SoloStar® 300 UI/ml	p.4
Radiation de la liste PHEL		
Analgésique opioïde	Temgesic® 0.3 mg/ml, ampoule	p.8
Anti-allergique	Cetallerg® 10 mg/ml, goutte	p.8
Antianémique	Folsäure Hevert 5 mg/2 ml, solution injectable	p.8
Anticholinergique par inhalation	Atrovent ® N, aérosol doseur	p.8
Antiépileptique	Phenhydan® 250 mg/5 ml, solution injectable	p.8
Dermatologie	Talc mentholé 2 %, poudre externe	p.8
Hémostatique systémique	Dicynone® 500 mg, capsule	p.8
Insuline	Humalog® 100 UI/ml, fiole Insulatard® HM FlexPen® 100 UI/ml Lantus® SoloStar® 100 UI/ml Lantus® 100 UI/ml, cartouche Levemir® FlexPen® 100 UI/ml Tresiba® 100 UI/ml, cartouche Ryzodeg® FlexTouch® 100 UI/ml	p.3
Vitamine	Vitamine C Streuli® 20 %, solution injectable	p.8
Refus d'ajout / modification sur la liste PHEL		
Vasoconstricteur	Ephedrin HCl Bichsel® 25 mg/5 ml, solution injectable	p.9

►NOUVEAUTES DANS L'ASSORTIMENT DES « MEDICAMENTS RESERVES » p.10

Ajout / Remplacement dans l'assortiment des médicaments réservés		
Analgésique	Morphine sulfate Sintetica® 1 mg/ml, poche 100 ml ► réservé pour l'anesthésie, la Fondation Rive-Neuve et l'Hôpital de Lavaux	p.5
Anticholinergique par inhalation	Atrovent ® N, aérosol doseur ► réservé pour les soins intensifs	p.8
Antiémétique	Ondansétron Tecrapharm® remplace Ondansétron Sandoz® 4 mg/5 ml, sirop ► réservé pour la pédiatrie	p.12
Dérivé nitré	Isoket® 10 mg/10 ml, concentré pour perfusion ► réservé pour la salle de cathétérisme	p.10
Enzyme fibrinolytique	Actilyse® substance sèche 20 mg ► réservé pour la stroke Unit	p.10
Inhibiteur calcique	Isoptin® (IMP D) 5 mg/2 ml ► réservé pour la salle de cathétérisme	p.10
Inhibiteur de la cholinestérase	Exelon® 4.5 mg, capsule	p.10
Insuline	Humalog® KwikPen® 100 UI/ml, stylo Novorapid® FlexPen® 100 UI/ml, stylo Tresiba® FlexTouch® 100 UI/ml, stylo ► réservés pour le service de diabétologie	p.3
Lubrifiant	Paraffine liquide stérile PHEL remplace Paraffine liquide Bichsel®	p.12
Nutrition parentérale, vitamines et oligo-éléments	Numeta Neo®, poche à 3 compartiments ► réservé pour la néonatologie	p.11
	Peditrace®, ampoule 10 ml Soluvit®, ampoule sèche 10 ml Vitalipid® N infant, ampoules 10 ml ► réservés pour la néonatologie	p.11
Produit diagnostic	Verdye® 25 mg, ampoule ► réservé pour le bloc opératoire	p.10
Tocolytique	Atosiban Labatec® remplace Tractocile Ferring® 6.75 mg/0.9 ml, solution injectable et 37.5 mg/5 ml, concentré pour perfusion ► réservé pour le bloc obstétrical et la gynécologie	p.12

►AUTRES SUJETS p.13

Analyse de la gamme des bétabloquants	p.13
Fiche de sécurité des produits chimiques	p.14

PHELinfos est un organe d'information destiné au corps médical, aux infirmier·ère·s, aux assistant·e·s en pharmacie et aux pharmacien·ne·s des Hôpitaux de l'Est lémanique.

RÉDACTION DU N° 89

Charline Pellaton, pharmacienne ;
Stéphanie Spaggiari, pharmacienne ;
Virginie Berthaut, pharmacienne ;
Yasmin Meystre, assistante en pharmacie ;
Dr Nicolas Widmer, pharmacien-chef.

Adresse : Pharmacie des Hôpitaux de l'Est Lémanique (PHEL)
Route du Vieux Sequoia 20, CH-1847 Rennaz
Tél. : 058 773 42 00
Fax : 058 773 42 31
E-mail : charline.pellaton@phel.ch ; nicolas.widmer@phel.ch

Illustration de couverture : © François Rouiller

www.phel.ch

QUOI DE NEUF SUR LA LISTE DES MÉDICAMENTS ?

La Commission des médicaments des hôpitaux de l'Est lémanique, réunie le **12 mars 2025**, a décidé d'apporter des modifications à la Liste des médicaments de la PHEL. Ces changements, détaillés dans ce PHELinfos, sont mis en œuvre progressivement en fonction des contraintes logistiques propres à chaque produit. Certains seront déjà appliqués au moment de la publication, tandis que d'autres arriveront par la suite. Les mises à jour sont communiquées au fur et à mesure via les fiches-infos.

Retrouvez toutes les fiches-infos concernant, notamment, les changements dans l'assortiment sur notre site internet (www.phel.ch > Informations médicaments > Fiches-infos).

RÉVISION DE LA GAMME DES INSULINES

GROUPE DE TRAVAIL « INSULINOTHÉRAPIE »

Révision générale de la gamme des insulines

Suite à divers incidents déclarés par les différents services de l'Hôpital Riviera-Chablais (HRC) et analysés en Commission de pharmacovigilance, un groupe de travail traitant de l'insulinothérapie a été mandaté par le bureau des affaires cliniques de l'HRC.

Afin d'optimiser la sécurité du circuit des insulines à l'HRC, une adaptation des insulines en liste PHEL fait partie des mesures d'amélioration proposées par le groupe de travail.

- **Distinguer visuellement les insulines** rapides et lentes pour éviter les confusions. Le prélèvement de doses d'insulines lentes à partir de cartouche n'est plus recommandé.

Fiole



uniquement pour les insulines rapides, lors des schémas de correction

Stylo nominatif



insulines rapides et lentes

- **Limiter le nombre de références en liste :** la liste des insulines en liste a été optimisée afin de diminuer les redondances (voir tableau suivant). La gamme des insulines pour la pédiatrie n'a pas été modifiée.

  Le fabricant NovoNordisk® a annoncé un arrêt de fabrication de diverses spécialités courant 2025 ; la liste suivante a pris en compte ces futures modifications du marché suisse.

- **Conserver les insulines habituelles des patient·e·s** : les insulines habituelles des patient·e·s ne pouvant pas être changées pour une insuline en stock seront commandées afin d'assurer la continuité du traitement administré.

Pour rappel : Un tableau récapitulatif des insulines et analogues est disponible sur le site internet de la PHEL (www.phel.ch > Documents d'assistance pharmaceutique > Endocrinologie > Insulines et analogues: tableau comparatif)

DCI	Spécialités	Commentaires
Insuline rapide		
insuline humaine	Actrapid®100 UI/ml, fiole	Insuline IV de référence
insuline lispro	Humalog® KwikPen® 100 UI/ml, stylo	Insuline rapide en stylo pour les schémas d'administration basale/bolus gérés par le patient ou en phase d'apprentissage
	Humalog® 100 UI/ml fiole	➔ switch sur Novorapid® fiole (schéma de correction + antidote)
insuline aspart	Novorapid® FlexPen® 100 UI/ml, stylo	
	Novorapid® 100 UI/ml fiole	Insuline rapide de référence pour les schémas de correction
Insuline durée intermédiaire / longue		
insuline humaine	Insulatard® HM 100 UI/ml, fiole	Insuline de durée intermédiaire pour les situations telle que les diabètes cortico-induits sous prednisone
	Insulatard® HM FlexPen® 100 UI/ml, stylo	Retrait du marché prévu ➔ switch sur Insulatard® fiole
insuline glargine	Lantus® 100 UI/ml, cartouche	
	Lantus® SoloStar® 100 UI/ml, stylo	Initiation de traitement : ➔ switch sur Toujeo® Suite de traitement : conserver Lantus®
	Toujeo® SoloStar® 300 UI/ml, stylo	Mise en liste pour remplacer Lantus® SoloStar® 100 UI/ml, stylo, lors d'initiation de traitement
insuline detemir	Levemir® FlexPen® 100 UI/ml, stylo	Retrait du marché prévu ➔ switch sur autres insulines (Insulatard® fiole)
insuline degludec	Tresiba® FlexTouch® 100 UI/ml, stylo	Peu utilisée en phase aigüe mais utile pour les diabètes stabilisés comme par exemple en réadaptation
	Tresiba® 100 UI/ml, cartouche	➔ switch sur Tresiba® FlexTouch®, stylo
insuline degludec 70 % + aspart 30 %	Ryzodeg® FlexTouch® 100 UI/ml, stylo	Retrait du marché prévu ➔ administration des insulines sous forme dissociée (basale/bolus)

✓ *En liste* ✓ *Dans l'assortiment des médicaments réservés pour les suites de traitement* ✗ *Retiré de la liste*

Pour rappel, les stylos à insuline sont personnels et ne doivent être utilisés que pour un·e seul·e et même patient·e à qui on le remettra à la fin du séjour hospitalier si le traitement est poursuivi.

L'utilisation d'un stylo à insuline pour plus d'un·e patient·e, même en changeant l'aiguille, peut entraîner la transmission du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), de l'hépatite B, de l'hépatite C ou d'autres agents pathogènes transmissibles par le sang. Il est donc **indispensable** d'étiqueter les stylos au nom du patient.

La Directive institutionnelle relative à la sécurité des médicaments de l'HRC sera modifiée en ce sens dans les prochains mois.



Stylo pré-rempli : Les stylos à insuline entamés seront remis au·à la patient·e lors de la sortie d'hôpital dans un but de diminution du gaspillage.

Il est de même pour les autres stylos d'insuline débutés en milieu hospitalier et devant être poursuivis à domicile.

TOUJEO® SOLOSTAR® 300 UI/ML, STYLO PRÉ-REMPLI

Insuline glargine

A l'heure actuelle, l'insuline glargine est représentée par Lantus® 100 UI/ml sur la liste des médicaments. Il s'agit d'une insuline lente jusqu'ici largement prescrite, aussi bien dans le domaine hospitalier qu'en ambulatoire.

Depuis le 1e décembre 2024, le remboursement ambulatoire de Lantus® SoloStar® a changé avec une quote-part passant de 10 % à 40 % *(plus d'informations concernant le remboursement des biosimilaires : PHELinfos n°87)*. Cette augmentation des coûts entraînera probablement une baisse des prescriptions en ambulatoire ainsi qu'une diminution des initiations en milieu hospitalier. Une alternative à Lantus® est Abasaglar®, son biosimilaire, pour lequel la quote-part reste à 10 %, mais à l'heure actuelle ce produit est difficilement obtenable car contingenté.

Toujeo® SoloStar® est une insuline glargine également mais 3x plus concentrée (300 UI/ml) ce qui lui confère une libération prolongée depuis le dépôt sous-cutané donc un effet plus régulier et plus long. Cette insuline hautement dosée convient pour tous patients nécessitant une insuline glargine et a principalement sa place chez des patients hautement insulino-résistant nécessitant des doses d'insuline glargine >30 UI/j (diabète type II, obésité, diabète cortico-induit en oncologie) car sa haute concentration assure une meilleure diffusion cutanée.

Un switch vers Toujeo® pour des patients déjà sous insuline glargine à 100 UI/ml (ex. Lantus®) semble plus délicat car la stagnation du principe actif hautement concentré dans les tissus sous-cutanés, réduit la biodisponibilité d'où la nécessité de recourir à des doses plus élevées (10-20 %) qu'avec une insuline glargine à 100 UI/ml. Cette nécessité d'ajustement de dose justifie, d'un point de vue sécuritaire, le maintien en stock hors-liste l'insuline glargine 100 UI/ml pour les suites de traitement des patients qui seraient sous Lantus® ou biosimilaire à domicile.

En pratique

Initiation d'un nouveau traitement par insuline lente	→ Toujeo® SoloStar® 300 UI/ml, stylo pré-rempli
Poursuite de traitement d'un·e patient·e arrivant sous Toujeo® SoloStar® 300 UI/ml	
Poursuite de traitement d'un·e patient·e sous insuline glargine 100 UI/ml (ex. Lantus® ou Abasaglar®)	→ Lantus® SoloStar® 100 UI/ml, stylo pré-rempli

Ne pas switcher d'une insuline glargine 300 UI/ml (Toujeo®) à une insuline glargine 100 UI/ml (ex. Lantus® ou Abasaglar®) sans avis diabétologique.



Ajout : Toujeo® SoloStar® 300 UI/ml, stylo pré-rempli
Radiation : Lantus® SoloStar® 100 UI/ml, stylo pré-rempli

Sources :

(1) Owens DR. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of insulin glargine 300 U/mL in the treatment of diabetes and their clinical relevance. Expert Opin. Drug Metab. Toxicol. 2016;12(8):977-87.

(2) Swissmedicinfo. www.swissmedicinfo.ch (consulté en mars 2025)

AJOUTS SUR LA LISTE PHEL

Classe thérapeutique	Produit (principe actif)	Commentaires
Analgésique	Morphine sulfate 1 mg/ml, cassette 100 ml (morphine)	Pour plus d'information, se référer au paragraphe en lien.
Antidépresseur	Sertraline® Sandoz 100 mg, comprimé (sertraline)	**Élargissement de gamme** Déjà en liste : Sertraline® Sandoz 50 mg, comprimé

MORPHINE SULFATE® 1 MG/ML, MÉDICASSETTE 100 ML

Analgésique (morphine)

Depuis le 6 janvier 2025, le secteur Fabrication de la PHEL reconstitue de façon aseptique les cassettes de morphine sulfate 1 mg/ml (100 ml), destinées aux PCA (Patient-Controlled-Analgesia) pour ses hôpitaux membres. La plus-value de ces cassettes prêtes à l'emploi, aussi appelées « médicassettes », est un gain de temps pour les soignant·e·s, une meilleure sécurité, ainsi qu'une meilleure stabilité microbiologique. En effet, ces cassettes sont stables 7 jours lorsqu'elle sont préparées dans des conditions aseptiques alors qu'une reconstitution directement dans les services limitent la conservation à 24 heures.

Administration

Afin d'éviter le risque de confusion entre les différentes médicassettes disponibles (fentanyl et morphine), un code couleur a été mis en place :

- Médicassette de morphine : couleur jaune
- Médicassette de fentanyl : couleur grise

Par ailleurs, le paramétrage des pompes a été mis à jour, ainsi que les protocoles de pose des PCA, disponibles sur le site de la PHEL (www.phel.ch). Ils présentent deux volets : un premier avec le branchement simple des cassettes prêtes à l'emploi, et un deuxième correspondant à un « mode dégradé », dans l'éventualité d'une rupture d'approvisionnement.

- PCA Fentanyl
- PCA Morphine 1 mg/ml



Ajout : Morphine sulfate 1 mg/ml, Médicassette 100 ml

Passage dans l'assortiment des médicaments réservés (AMR) : Morphine sulfate Sintetica® 1 mg/ml, poche 100 ml, réservé pour l'anesthésie de l'HRC, l'Hôpital de Lavaux et la Fondation Rive-Neuve

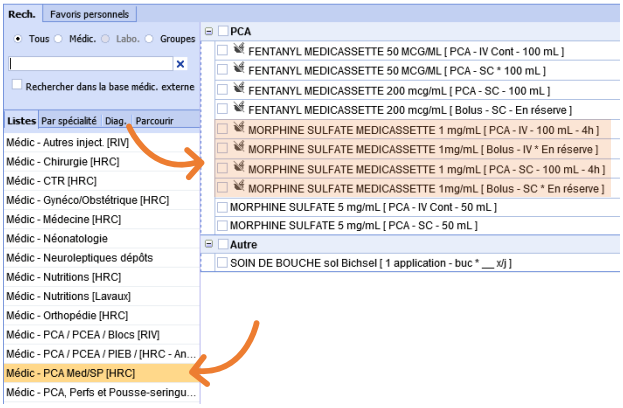
Prescription

Sur Soarian®, les PCA ne figurent pas dans la recherche globale dans une optique de diminution du risque de prescription par inadvertance et de confusion avec les autres formes galéniques.

Ainsi elles se prescrivent en choisissant « médicassettes » dans les *picklistes* suivantes :

- HRC et la Fondation de Nant : Médic - PCA Med/SP [HRC]
- **Hôpital de Lavaux :** Médic – PCA, Perfs et Pousse-seringue [Lavaux]
- **Fondation Rive-Neuve :** Médic- PCA/PCEA /Blocs [RIV]

Les pompes du PSPE n'étant pas compatibles avec ces médicassettes, ce changement ne les concerne pas.



Poches de Morphine sulfate 1 mg/ml (100 ml)

À l'**HRC**, jusqu'à présent, les cassettes étaient uniquement reconstituées par les soignants du service d'anesthésie à partir des poches de morphine sulfate 1 mg/ml, 100 ml. L'utilisation de ces poches devrait donc diminuer avec l'ajout de cassettes en liste. Il est toutefois nécessaire de garder les poches à 100 ml en stock car elles restent utilisées pour le mélange morphine–kétamine.

La **Fondation Rive-Neuve** et l'**Hôpital de Lavaux** conservent, en parallèle, également un stock de poches pour les situations urgentes ou spécifiques afin de pouvoir préparés eux-mêmes les cassettes.

Les poches de Morphine sulfate® 1 mg/ml (100 ml) sont donc retirées de la liste des médicaments et sont ajoutées à l'assortiment des médicaments réservés, pour le service d'anesthésie de l'HRC, la Fondation Rive-Neuve et l'Hôpital de Lavaux.

REMPLACEMENTS SUR LA LISTE PHEL

Classe thérapeutique	Ancien produit	Remplacé par	Nouveau produit	Commentaires
Antidote et électrolyte	Calcium gluBIOnate 90 mg/10 ml, solution injectable (calcium glubionate)	→	Calcium gluconate 10 %, miniplasco 10 ml (calcium gluconate)	Pour plus d'informations, se référer au paragraphe en lien.
Antibiotique	Cefuroxim Labatec® 750 mg et 1.5 g, poudre pour solution injectable (céfuroxime)		Cefuroxim Fresenius® 750 mg et 1.5 g, poudre pour solution injectable (céfuroxime)	**Remplacement : changement de fournisseur**
	Delamoxyl® 500 mg et 1 g, poudre pour solution injectable (amoxicilline)		Amoxicillin OrPha® 500 mg et 1 g, poudre pour solution injectable (amoxicilline)	**Remplacement : changement de fournisseur**
Anticoagulant	Heparine Sintetica® 20'000 UI/48 ml (héparine sodique porcine)		Heparine Bichsel® 20'000 UI/48 ml (héparine sodique porcine)	**Remplacement : changement de fournisseur** **Pour rappel :** Un document récapitulant les héparines disponibles à la PHEL est accessible sur notre site internet (www.phel.ch) > Administration > Héparines – Produits de la liste des médicaments). L'héparine IV faisant partie des médicaments à haut risque, différentes barrières de sécurité touchant la commande, le stockage, la prescription, la préparation et l'administration sont en place à l'HRC. Plus d'infos dans le Vigi-Flash d'octobre 2023 : Vigi-flash - Octobre 2023 (Héparine)
	Xarelto® 10 mg, 15 mg et 20 mg, comprimé (rivaroxaban)		Rivaroxaban Sandoz® 10 mg, 15 mg et 20 mg, comprimé (rivaroxaban)	**Remplacement : changement de fournisseur** (passage de l'original au médicament générique)
Antidote	LIPOFUNDIN MCT LCT® 20 % 250 ml, solution injectable		SMOFlipid® 20 % 250 ml, solution injectable	**Remplacement : produit hors-commerce** Nécessité d'avoir un remplacement en tant qu'antidote, utilisé contre la toxicité cardiovasculaire d'anesthésiques locaux lipophiles. **Pour rappel :** Toutes les informations liées aux antidotes sont disponibles sur notre site internet (www.phel.ch) > en bas à droite : En urgence > Antidotes.

CALCIUM GLUCONATE REMPLACE CALCIUM GLUBIONATE

Antidote et électrolyte (calcium glubionate)

Le calcium injectable est un médicament indispensable dans de nombreux contextes cliniques d'urgence, notamment comme électrolyte dans les cas d'hypocalcémies sévères, mais également comme antidote. Dans cette indication, son administration est recommandée en urgence lors d'arrêt cardiorespiratoire lié à une hyperkaliémie ou une hypermagnésémie ou en cas d'intoxication par les inhibiteurs des canaux calciques, les bétabloquants ou par l'acide fluorhydrique. Il est également utilisé pour répléter les stocks de calcium chez les patients sous hémodialyse bénéficiant d'une anticoagulation au citrate. Dans l'ensemble des recommandations de prise en charge de ces situations, l'utilisation de calcium injectable sous la forme de gluconate de calcium est mentionnée.

Depuis le retrait du marché suisse des ampoules de Calcium-Sandoz® en 2017, le calcium injectable (gluBIOnate de calcium) en liste à la PHEL est fabriqué par le laboratoire Bichsel spécifiquement pour l'usage hospitalier. Chaque ampoule de 10 ml contient 1'375 mg de sel de calcium sous forme de gluBIOnate, correspondant à une concentration en calcium élémentaire de 90 mg par ampoule (=2.25 mmoles/amp).

Le calcium gluBIOnate n'est malheureusement pas référencé dans la Pharmacopée Helvétique, Européenne ou Américaine. Cette absence de mention dans les registres indique qu'il n'existe pas de normes de qualité officielles pour cette substance et aucune méthode d'analyse définie pour en attester la qualité. Les données à disposition concernant ce sel sont donc lacunaires dans la littérature.

Pour rappel : Un tableau récapitulatif des calciums disponibles est référencé sur le site internet de la PHEL (www.phel.ch > Documents d'assistance pharmaceutique > Nutrition, électrolytes, vitamines/minéraux > Calcium: prescription et administration)

De plus, dans ces recommandations posologiques, les doses sont exprimées en millilitres ou, dans le meilleur des cas, en milligramme de sel

de calcium sous sa forme gluconate (1 g de calcium gluconate = 93 mg de Ca^{2+} = 2.25 mmol de Ca^{2+}). Cela pose un problème sécuritaire en raison du risque d'erreur de calcul de la dose en convertissant les posologies proposées vers le gluBIOnate de calcium. Même si une ampoule de calcium gluBIOnate correspond à une ampoule de calcium gluconate 10%, cette équivalence, n'est pas intuitive et l'étiquette de l'ampoule du produit Bichsel ne mentionne pas la dose en millimoles de calcium rendant les conversions peu sécuritaires.

Les données de compatibilités physicochimiques et de stabilité pour le calcium gluBIOnate sont largement absentes dans la littérature et, pour ces raisons, il n'est pas possible de préparer une solution concentrée et son utilisation par voie intraveineuse en continu impose de bloquer une voie pour son administration. Pour le calcium gluconate, les données de compatibilité et de stabilité sont plus étendues permettant, notamment, son administration simultanées (en Y) avec certains autres médicaments, comme l'insuline, et sa dilution dans un volume 5 fois inférieur. Ces avantages sont importants notamment pour le service des soins critiques de l'HRC et plus généralement dans les situations de restrictions hydriques.

Pour toutes ces raisons, la Commission des médicaments a fait le choix de remplacer le calcium glubionate par le calcium gluconate.

Le calcium gluconate n'est pas disponible en Suisse mais la spécialité allemande peut être importée facilement. Elle se présente sous forme de mini-plasco de 10 ml. Pour garantir une prescription sécurisée, la PHEL recommande de prescrire la dose en mmol, conformément aux paramètres préprogrammés dans Soarian® :

1 miniplasco de 10 ml contient :

1 g de calcium gluconate = 2.25 mmol de Ca^{2+}

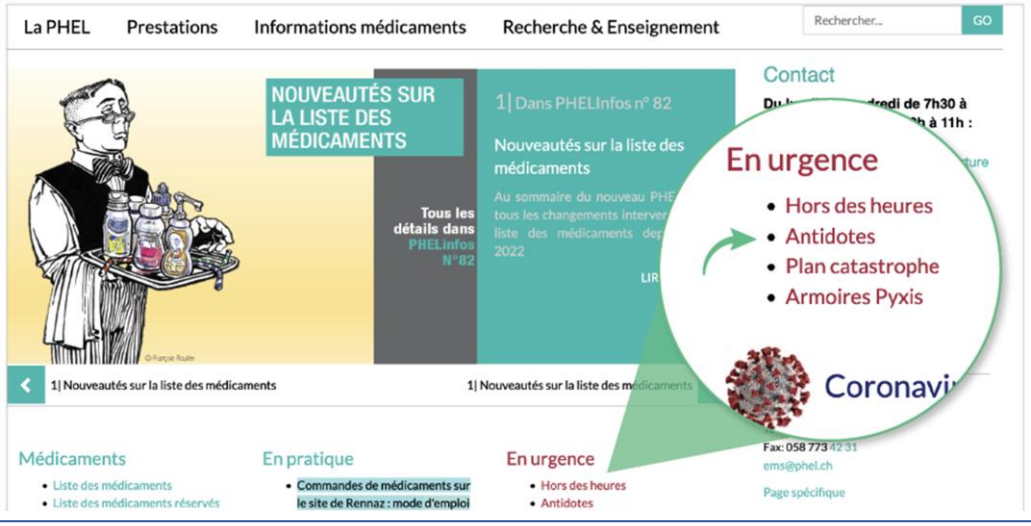


Ajout : Calcium gluconate® 10 %, mini-plasco 10 ml

Radiation : Calcium gluBIOnate® 90 mg/10 ml, ampoule

Pour rappel : Toutes les informations liées aux antidotes sont disponibles sur notre site internet (www.phel.ch) > en bas à droite : En urgence > Antidotes.

Un document récapitulant tous les antidotes disponibles dans les différents établissements membres de la PHEL est également disponible sur cette page : Assortiment d'antidotes.



Sources :

(1) Turner J, Gittoes N, Selby P. SOCIETY FOR ENDOCRINOLOGY ENDOCRINE EMERGENCY GUIDANCE: Emergency management of acute hypocalcaemia in adult patients. Endocr Connect. 2016;5(5):G7-G8.

(2) Vanden Hoek TL, Morrison LJ, Shuster M, et al. Part 12: Cardiac Arrest in Special Situations. Circulation. 2010/11/02 2010;122(18_suppl_3):S829-S861.

(3) Tox Info Suisse. Acide fluorhydrique: intoxications et brûlures. Mise-à-jour mars 2018. https://www.toxinfo.ch/customer/files/930/MB_Flussaeure_f_2018.pdf

(4) OFSP. Antidotes contre les intoxications 2024/2025. https://www.toxinfo.ch/customer/files/931/Liste-des-Antidotes.pdf

(5) Micromedex Drugs' database. https://www.micromedexsolutions.com/ (consulté le 26.03.2025)

RADIATIONS DE LA LISTE PHEL

Produits dormants ou hors commerce

Un produit dormant est un article pour lequel le logiciel de gestion de stock de la pharmacie (Opale®) n'a enregistré que très peu ou pas de mouvements de stock depuis une année.

La Commission des médicaments s'est prononcée en faveur d'une radiation de la liste des produits suivants ; ces produits, s'il ne s'agit pas de produits hors-commerce, peuvent toutefois être commandés expressément chez le grossiste, voire fabriqués, en cas de besoin indispensable.

Classe thérapeutique	Produit (principe actif)	Commentaires
Analgésique opioïde	Temgesic® 0.3 mg/ml, ampoule (buprénorphine)	**Radiation : produit hors-commerce** Alternatives en liste : ▶ Transtec® (buprénorphine), patchs à 35, 52.5 et 70 µg/h ▶ Temgesic® (buprénorphine), comprimés sublinguaux à 0.2 mg et 0.4 mg ▶ Fentanyl® (fentanyl), solution injectable à 0.1 mg/2 ml et 0.5 mg/10 ml
Anti-allergique	Cetallerg® 10 mg/ml, goutte (cétirizine)	**Radiation : produit hors-commerce** Alternatives en liste : ▶ Feniallerg® (dimenthindène) 1 mg/ml, goutte ▶ Cetallerg® (cétirizine) 10 mg, comprimé
Antianémique	Folsäure Hevert 5 mg/2 ml, solution injectable – *importation d'Allemagne* (acide folique)	**Radiation : simplification de gamme,** pas utilisé en 2024 Alternative en liste : Acidum folicum Streuli® 5 mg, comprimé
Anticholinergique par inhalation	Atrovent® N, aérosol doseur (ipratropium)	Pour plus d'informations, se référer au paragraphe en lien
Antiépileptique	Phenhydan® 250 mg/5 ml, solution injectable (phénytoïne)	**Radiation : produit dormant.** Ne fait plus partie des protocoles d'urgence pour le traitement des crises d'épilepsie. Alternative en liste : Phenhydan® 100 mg, comprimé
Dermatologie	Talc mentholé 2 %, poudre externe	**Radiation : produit dormant** Alternative en liste : Talc Ph. Eur., poudre externe
Hémostatique systémique	Dicynone® 500 mg, capsule (étamsylate)	**Radiation : produit dormant** Alternative en liste : Dicynone® 250 mg/2 ml, solution injectable
Inhibiteur de la cholinestérase	Exelon® 4.5 mg, capsule (rivastigmine)	**Radiation : produit dormant** Alternative en liste : ▶ Exelon® 3 mg, capsule ▶ Exelon® 9.5 mg/24h, patch
Vitamine	Vitamine C Streuli® 20 %, 5 ml, solution injectable (acide ascorbique)	**Radiation : produit hors-commerce**

ATROVENT® N, AÉROSOL DOSEUR : À RÉSERVER À CERTAINES SITUATIONS SPÉCIFIQUES DES SOINS INTENSIFS

Anticholinergique par inhalation (bromure d'ipratropium)

Atrovent® N contient du bromure d'ipratropium, un bronchodilatateur anticholinergique à courte durée d'action (SAMA) indiqué pour le traitement du bronchospasme associé aux bronchopneumopathies obstructives chroniques (BPCO) ou dans l'asthme aigu. Son action dilatatrice des voies respiratoires est rapide (15 minutes) et dure en moyenne 4 à 6 heures. Dans les crises d'asthme sévère, un traitement bêta 2 stimulant comme le salbutamol (ex. Ventolin®) est en principe recommandé en première ligne de traitement. Le bromure d'ipratropium est utilisé en combinaison, au même titre que d'autres médicaments comme les corticostéroïdes ou le sulfate de magnésium intraveineux selon la sévérité de l'exacerbation.

Atrovent® N aérosol doseur (AD) est hors-commerce en Suisse. Son approvisionnement en Europe est également compromis en raison d'un arrêt général de commercialisation par le fabricant. Il existe toutefois des alternatives sous forme d'aérosol-doseur en Europe auprès d'autres fabricants.

Ce retrait implique qu'il n'existe plus, sur le marché suisse, d'AD composé uniquement de SAMA. Par contre, l'ipratropium sous forme d'AD est présent dans le produit combiné suivant (en liste PHEL) :

- Berodual® N (fenotérol, ipratropium) : association SAMA / SABA

L'administration des médicaments par aérosol doseur est la technique à privilégier pour la majorité des situations cliniques rencontrées à l'hôpital. Cette technique nécessite moins de ressources que l'administration par nébulisation (matériel, personnel, temps) et à l'avantage de permettre l'enseignement thérapeutique de l'utilisation du dispositif voir de la chambre d'inhalation aux patient·e·s durant leur séjour hospitalier.

Pour une administration par nébulisation, les solutions d'inhalations, en liste PHEL, composées d'ipratropium seul ou en association sont les suivantes :

- Atrovent® (ipratropium) : SAMA
- Dospir® (ipratropium, salbutamol) : association SAMA / SABA

Au sein de l'HRC, la nébulisation n'est en principe recommandée que lorsque le médicament prescrit n'existe pas en aérosol-doseur car elle nécessite l'utilisation d'un compresseur puisque la majorité des services n'ont pas de prise d'air au mur (2ème étage de l'hôpital) et des ressources importantes en matériel et en personnel pour son administration. De plus, le·la patient·e doit être positionné·e assis·e verticalement dans son lit pendant toute la durée de la nébulisation (plus longue que l'AD).

Le produit Berodual® N (ipratropium, fénotérol) – une association de SAMA et SABA – est donc l'alternative sous forme d'AD en stock à privilégier. Issu du même fabricant, il sera prochainement retiré du marché suisse, mais la PHEL reste attentive à son approvisionnement et importera un équivalent étranger lors de l'arrêt effectif de sa commercialisation.

Une stratégie d'épargne du produit Atrovent® N a été décidée en collaboration avec et les pneumologues et les intensivistes pour réserver les stocks de Atrovent® AD aux patient·e·s nécessitant une administration par aérosols-doseurs aux soins critiques.

- **Aux soins critiques (HRC)**, en cas d'intubation, l'administration de médicaments bronchodilatateurs peut s'avérer nécessaire selon le contexte clinique et l'utilisation d'AD est alors préférée à la nébulisation. En effet, l'administration de molécules nébulisées s'avère peu efficace notamment en raison de l'impaction des molécules dans le circuit de ventilation.

  Pour l'administration chez un patient intubé, retirer le récipient sous pression du dispositif et le placer sur le circuit conformément à la directive existante *(document interne à l'HRC : Aérosolthérapie chez un patient intubé, Soins Critiques - GED HRC - Intranet)*.

  Dans la ventilation non invasive (VNI), en plus de cette problématique d'impaction dans le circuit, on observe un dépôt important du médicament dans les voies aériennes supérieure en raison du système d'administration (masque) ainsi qu'un manque de synchronisation entre l'activation du dispositif et l'inspiration du médicament. Pour ces raisons, au vu du caractère intermittent de la VNI, une administration des traitements inhalés entre les séances de ventilation est à privilégier. Si cela n'est pas réalisable, l'utilisation d'un dispositif AD est également à privilégier.

  Les stocks restant d'Atrovent® N sont réservés à ces administrations spécifiques nécessitant l'utilisation d'un AD.

  Pour les autres situations les autres produits en liste seront utilisés selon le contexte clinique : soit Berodual® N en AD soit les solutions d'inhalation à savoir Atrovent® (ipratropium) +/- Ventolin® (salbutamol) ou Dospir® (ipratropium et salbutamol).

- **Concernant le service de pédiatrie (HRC)**, celui-ci est informé et les protocoles de prise en charge de l'asthme aigu seront adaptés en conséquence et alignés sur les recommandations nationales *(document interne à l'HRC : Prise en charge des crises d'asthme aux urgences pédiatriques - GED HRC - Intranet)*. L'administration d'Atrovent® (ipratropium) solution d'inhalation sera privilégiée en cas de crise d'asthme. L'éducation thérapeutique pourra être réalisée avec le Ventolin® (salbutamol) en AD avec la chambre d'inhalation qui reste bien entendu disponible.

- **Trachéostomie**, l'administration d'AD peut se faire à l'aide d'une chambre d'inhalation spécifique directement positionnée sur la trachéostomie.

Pour rappel : Un tableau récapitulatif des dispositifs d'inhalation disponibles en Suisse est à disposition sur le site internet de la PHEL (www.phel.ch > Documents d'assistance pharmaceutique > pneumologie > Asthme et BPCO : dispositifs médicaux).

Ce document catégorise également les dispositifs d'inhalation selon leur impact carbone en estimant l'équivalent CO_2 par inhalateur :

- >20 kg (= trajet de 185 km avec une voiture diesel) ► **Exemple : Atrovent®**
- 1-20 kg (= trajet de 50-120 km)
- < 1 kg

Radiation : Atrovent® N, aérosol doseur

Ajout dans l'assortiment des médicaments réservés (AMR) : Atrovent® N, aérosol doseur, réservé pour les soins intensifs

Sources :

(1) Compendium suisse des médicaments. https://compendium.ch/ (consulté le 26.03.2025)
(2) Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2024;
(3) Dequin P, Mercier E. Nébulisation de médicaments sous ventilation mécaniqueInhalational therapy during mechanical ventilation. Réanimation. 2003;12(1):62-70.
(4) HRC. Aérosolthérapie. 2024.
(5) Réminiac F, Bodet-Contentin L, Vecellio L, et al. Aérosolthérapie au cours de l'assistance respiratoire non invasive. Réanimation. 2016;25(1):11-20.

REFUS DE MODIFICATION SUR LA LISTE DES MÉDICAMENTS

Classe thérapeutique	Produit (principe actif)	Commentaires
Vasoconstricteur	Ephedrin HCl Bichsel® 25 mg/5 ml, solution injectable (éphédrine)	**Refus de remplacement** de l'Ephedrin Sintetica® 50 mg/10 ml par l'Ephedrin HCl Bichsel® 25 mg/5 ml ; bien que la concentration soit identique, le volume change entre les deux spécialités. Le risque de confusion avec la phényléphrine (même volume, même couleur d'étiquette), également utilisé comme médicament d'urgence, est trop élevé.

QUOI DE NEUF DANS L'ASSORTIMENT DES MÉDICAMENTS RÉSERVÉS ?

AJOUTS DANS L'ASSORTIMENT DES MÉDICAMENTS RÉSERVÉS

Rappelons que l'assortiment des médicaments réservés (AMR), édité en supplément de la liste PHEL, correspond à un stock permanent de médicaments jugés indispensables dans certaines circonstances, mais assortis d'une limitation de prescription qui justifie leur statut de « hors-liste ». Celui-ci peut également être consulté sur le site internet de la PHEL, www.phel.ch.

La pharmacie centrale tient en stock ces médicaments et peut donc les livrer aussi rapidement qu'un médicament de la liste. Ceux-ci ne sont toutefois fournis sans l'exigence d'une ordonnance interne que s'ils remplissent certaines conditions.

Classe thérapeutique	Produit® (Principe actif)	Commentaires
Analgésique	Morphine sulfate Sintetica® 1 mg/ml, poche 100 ml ▶ réservé pour l'anesthésie	Pour plus d'informations, se référer au paragraphe en lien.
Anticholinergique par inhalation	Atrovent® N, aérosol doseur (ipratropium) ▶ stock restant réservé pour les soins intensifs	Pour plus d'informations, se référer au paragraphe en lien
Dérivé nitré	Isoket® 10 mg/10 ml, concentré pour perfusion (dinitrate d'isosorbide) ▶ réservé à la salle de cathétérisme	Ce dérivé nitré est utilisé en routine en injection intra-coronaire lors d'une coronarographie/angioplastie pour dilater l'artère coronaire. Une fiche FAMI est disponible sur RefMed pour cette voie d'administration.
Enzyme fibrinolytique	Actilyse® substance sèche 20mg (altéplase) ▶ réservé pour la stroke Unit	Dans le contexte de l'ouverture de la stroke unit de l'HRC. Sa filière Thrombolyse nécessite d'avoir différents dosages d'altéplase afin de faciliter et sécuriser l'administration du bolus et de la perfusion basée sur le poids du patient. Dosages déjà présents dans l'assortiment des médicaments réservés (réservé aux urgences et soins intensifs de l'HRC) : ▶ Actilyse® 10 mg, substance sèche ▶ Actilyse® 50 mg, substance sèche
Inhibiteur calcique	Isoptin® 5 mg/2 ml, ampoule - *importation d'Allemagne* (vérapamil) ▶ réservé à la salle de cathétérisme	Le vérapamil est utilisé pour le traitement du slow flow ou no reflow lors d'une angioplastie. Lors de l'angioplastie, on peut emboliser du thrombus dans la microcirculation ; l'administration de vérapamil en **intra-coronaire** permet de vasodilater la microcirculation et favoriser un lavage du thrombus avec restauration d'un flux normal. Par ailleurs, le vérapamil peut aussi être administré par voie **intra-artérielle** pour atténuer le risque de spasme de l'artère radiale lors d'une angioplastie par voie radiale. Des fiches FAMI sont disponibles sur RefMed pour chacune de ces voies d'administration.
Nutrition parentérale	Numeta Neo®, poche à 3 compartiments ▶ réservé pour la néonatologie	Pour plus d'informations, se référer au paragraphe en lien
	Peditrace®, ampoule 10 ml ▶ réservé pour la néonatologie	
	Soluvit®, ampoule sèche 10 ml ▶ réservé pour la néonatologie	
	Vitalipid® N infant, ampoules 10 ml ▶ réservé pour la néonatologie	
Produit diagnostic	Verdye® 25 mg, ampoule (vert d'indocyanine) ▶ réservé au bloc opératoire (HRC)	Médicament à usage diagnostic pour visualisation des voies biliaires et angiographie de perfusion (anastomose digestive, parathyroïde).

NUTRITION PARENTÉRALE POUR LA NÉONATOLOGIE

Dès le 1er juin 2025, l'unité de néonatologie de l'HRC passera de la certification IIa à IIb. Cette évolution permettra d'accueillir les accouchements dès 32 semaines d'aménorrhée (SA) au lieu de 34 SA auparavant, ainsi que d'hospitaliser les nouveau-nés à partir d'un poids de 1250 g, contre 1500 g précédemment. De plus, cette nouvelle certification ouvre la possibilité de transferts depuis d'autres hôpitaux pour la poursuite de la prise en charge de patients stables dès 30 SA.

L'alimentation chez les nouveau-nés ayant un poids compris entre 1250 g et 1750 g consiste en une alimentation parentérale partielle, c'est-à-dire en complétement d'une nutrition entérale insuffisante.

Numeta Neo® (nutrition parentérale)

Numeta Neo® est une poche de nutrition parentérale tri-compartimentée (lipides, glucides, acides aminés/électrolytes). Avant administration, les compartiments doivent être ouverts en rompant les soudures puis mélangés.

Son principal avantage réside dans l'intégration d'un compartiment de lipides directement au sein de la poche, avec la possibilité de maintenir la soudure intacte ou de la rompre selon les besoins spécifiques en lipides. Contrairement aux autres poches de nutrition pédiatrique disponibles, où les lipides doivent être administrés séparément, via un pousse-seringue par exemple. De plus, Numeta Neo® représente la solution de nutrition parentérale la plus économique sur le marché suisse.

Numeta Neo® (volume total 300 ml) *N° Opale : 28004*	
	Composition pour **100 ml**
Acides aminés (g)	3.1
Glucose (g)	13.3
Lipides (g)	2.5
Sodium (mmol)	2.2
Potassium (mmol)	2.1
Magnésium (mmol)	0.16
Calcium (mmol)	1.3
Phosphate (mmol)	1.3
Energie non-protéique (kcal)	78
Energie totale (kcal)	91
Osmolarité approximative (mOsm/l)	1'150

Un protocole pour l'administration de Numeta Neo® et des vitamines et oligoéléments à y ajouter a été élaboré conjointement avec l'unité de néonatologie de l'HRC et est disponible sur le site internet de la PHEL (www.phel.ch > Documents d'assistance pharmaceutique > Pédiatrie > Nutrition parentérale en néonatologie).



Ajout dans l'assortiment des médicaments réservés, réservés pour la néonatologie **:**

- Numeta Neo®, poche à 3 compartiments
- Peditrace® (ampoule 10 ml),
- Soluvit® N (ampoule sèche 10 ml)
- Vitalipid® N infant (ampoule 10 ml)

Vitamines et oligoéléments à ajouter

Trois spécialités contenant des vitamines liposolubles, hydrosolubles et oligoéléments doivent être ajoutées directement dans la poche afin de subvenir aux besoins de l'enfant. Le choix de ces spécialités s'est fait en fonction des données de compatibilité disponibles avec Numeta Neo®.

La conservation et l'administration de Numeta Neo® doivent se faire à l'abri de la lumière, car l'exposition lumineuse peut altérer les composants de la nutrition parentérale. En effet, elle favorise la dégradation de certaines vitamines et la formation de peroxydes ainsi que d'autres produits de dégradation, pouvant entraîner des conséquences cliniques significatives, en particulier chez les prématurés.

Les tubulures et les poches doivent être protégées de la lumière. Le matériel nécessaire est à commander au magasin central :

- **Housse de photoprotection pour les poches (N° Opale : 117715)**
- **Tubulures opaques (N° Opale : 114417)**

Vitalipid® N Infant (*N° Opale : 27953*)	**Soluvit® N** (*N° Opale : 14132*)	**Peditrace®** (*N° Opale : 27954*)
1 ampoule de 10ml contient :	1 ampoule de 10 ml **reconstituée** contient :	1 ampoule de 10 ml contient :
		
Vitamine A (690 µg = 2300 UI) Vitamine D2 (10 µg = 400 UI) Vitamine E (6.4 mg = 7 UI) Vitamine K1 (200 µg)	Vitamine B1 (2.5 mg) Vitamine B2 (3.6 mg) Vitamine B6 (4.0 mg) Vitamine B5 (15 mg) Nicotinamide (40 mg) Biotine (60 µg) Acide folique (0.4 mg) Vitamine C (100 mg)	Cuivre (3.15 µmol) Manganèse (0.182 µmol) Iodure (0.078 µmol) Fluorure (30 µmol) Zinc (38.2 µmol) Sélénium (0.25 µmol)

Sources :

(1) Lapillonne A, Fidler Mis N, Goulet O, et al. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Lipids. Clin Nutr. 2018;37(6 Pt B):2324-2336.

(2) Bronsky J, Campoy C, Braegger C, et al. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Vitamins. Clin Nutr. 2018;37(6 Pt B):2366-2378.

REMPLACEMENTS DANS L'ASSORTIMENT DES MÉDICAMENTS RÉSERVÉS

Classe thérapeutique	Ancien produit	Remplacé par	Nouveau produit	Commentaires
Antiémétique	Ondansétron Sandoz® 4 mg/5 ml, sirop (ondansétron)	→	Ondansétron Tecrapharm® 4 mg/5 ml, sirop – *importation du Royaume-Uni* (ondansétron) ▶ Réservé pour la pédiatrie HRC	**Remplacement : produit hors-commerce** Les excipients du sirop de chez Tecrapharm® ont été validés pour une utilisation en pédiatrie.
Lubrifiant	Paraffine liquide Bichsel®, stérile, flacon 30 ml (paraffine)		Paraffine liquide stérile, fabriquée par le laboratoire de fabrication de la PHEL, flacon 20 ml (paraffine) ▶ Réservé pour le bloc opératoire de l'HRC	**Remplacement : produit hors-commerce**
Tocolytique	Tractocile Ferring® 6.75 mg/0.9 ml, solution injectable Tractocile Ferring® 37.5 mg/5 ml, concentré pour perfusion (atosiban)		Atosiban Labatec® 6.75 mg/0.9 ml, solution injectable Astosiban Labatec® 75 mg/10 ml, concentré pour perfusion (atosiban) ▶ Réservé pour le bloc obstétrical et la gynécologie	**Remplacement : changement de fournisseur**

AUTRES SUJETS

ANALYSE DE LA GAMME DES BÉTABLOQUANTS

À la suite d'un incident survenu lors du remplacement du nébivolol (un des seuls bétabloquants hors liste PHEL) par un bétabloquant de la liste lors d'une hospitalisation, la PHEL a décidé de mener une réflexion approfondie et de dresser un état des lieux complet de la gamme des bétabloquants disponibles dans nos établissements.

Les bêta-bloquants constituent une famille pharmacologique complexe et hétérogène, caractérisée par la capacité de ces médicaments à bloquer les récepteurs bêta-adrénergiques dans l'organisme. Leur action principale s'exerce sur les récepteurs β1 du cœur, β2 des vaisseaux et des bronches. Chaque bêta-bloquant possède des propriétés pharmacologiques uniques, notamment en termes de sélectivité pour les récepteurs bêta-adrénergiques, d'affinité pour les récepteurs alpha-adrénergiques, de solubilité lipidique, de métabolisme et d'élimination. Cette diversité pharmacologique se traduit par des indications et des profils d'effets indésirables spécifiques à chaque molécule.

Par conséquent, il n'est pas recommandé de switcher le traitement par bêta-bloquant d'un·e patient·e lors de son admission à l'hôpital.

Bien que certains établissements utilisent des tableaux d'équivalence entre bêta-bloquants, la politique de l'HRC, sur avis cardiologique, est de maintenir le traitement initial du·de la patient·e.

Outre ces bétabloquants qui figurent sur la liste PHEL, le nébivolol est maintenu en stock (hors-liste), le céliprolol et le nadolol sont commandés au cas par cas (hors-stock, hors liste). Dans le cas où un patient est sous un traitement non disponible dans la liste, la procédure consiste à commander le médicament spécifique si celui-ci n'est pas en stock central.

L'analyse de la gamme des bétabloquants en liste PHEL a montré qu'elle est conforme à l'utilisation actuelle et qu'aucune modification n'est souhaitable pour le moment.

Une simplification de gamme sera possiblement proposée dans une année (si la baisse des consommations récente est confirmée): elle concernerait un passage en AMR du labétatol cpr 100 mg réservé à la gynéco-obstétrique et une radiation de l'aténolol cpr 50 mg et 100 mg (bétabloquant peu utilisé, sans particularité par rapport au métoprolol et bisoprolol déjà en liste).

Un Flash-infos à l'intention des médecins-assistant·e·s est en cours de rédaction et fera partie du panel de formation disponible.

Un tableau récapitulatif des différents bétabloquants est disponible sur le site internet de la PHEL (www.phel.ch > Documents d'assistance pharmaceutique > Cardiologie > Bétabloquants per os : Tableau comparatif).

La liste PHEL actuelle comprend huit bétabloquants, illustrés dans les tableaux ci-dessous :

BÉTABLOQUANTS NON CARDIOSÉLECTIFS

DCI	Nom commercial	Forme galénique	Dosage
propranolol	INDERAL®	cpr	10 mg
			40 mg
carvédilol	CARVEDILOL®	cpr	6.25 mg
			12.5 mg
			25 mg
sotalol	SOTALOL®	cpr	80 mg
labétalol	TRANDATE®	cpr	100 mg
			200 mg
		amp iv	5 mg/ml

BÉTABLOQUANTS CARDIOSÉLECTIFS

DCI	Nom commercial	Forme galénique	Dosage
métoprolol	METOPROLOL®	cpr ret	25 mg
			50 mg
			100 mg
	BELOC®	amp iv	5 mg/ml
bisoprolol	BISOPROLOL®	cpr	2.5 mg
			5 mg
			10 mg
aténolol	TENORMIN®	cpr	50 mg
			« mite »
			100 mg
esmolol	ESMOLOL®	amp iv	100 mg/ml

Sources :

(1) The Best Practice Advocacy Centre New Zealand. Beta blockers for cardiovascular conditions: one size does not fit all. 2024. \\sadifs01\riviera$\98_PHELX\PHEL\Communication\PHEL-Infos\PHELinfos 89\www.bpac.org.nz\2024\beta-blockers.aspx

FICHE DE SÉCURITÉ DES PRODUITS CHIMIQUES

Les produits chimiques peuvent présenter des risques pour la santé et l'environnement s'ils ne sont pas manipulés correctement. Pour assurer une utilisation en toute sécurité, il est essentiel que chaque utilisateur·rice ait accès à des informations précises sur les dangers et les précautions à prendre.

La fiche de données de sécurité (FDS) relative à un produit chimique contient des informations sur les dangers potentiels du produit et fournit des indications concernant son utilisation, les mesures de protection appropriées, le stockage, le transport, l'élimination du produit ainsi que le comportement à adopter en cas d'accident.

En Suisse, la réglementation impose que toute substance chimique dangereuse soit accompagnée d'une **Fiche de Données de Sécurité (FDS)**.

Il est obligatoire que chaque commerçant·e et utilisateur·rice professionnel·le reçoive ces informations.

Afin de garantir la transparence et la conformité avec la réglementation, **tous les produits chimiques délivrés par la PHEL nécessitant une FDS ont été recensés**. Ces fiches sont accessibles sur notre site internet, permettant ainsi à chaque utilisateur·rice de consulter les informations essentielles à la sécurité et à la bonne utilisation des produits.

À noter que, dans nos divers établissements membres, la PHEL n'a pas l'exclusivité de l'approvisionnement en produits chimiques. Les FDS des produits obtenus par d'autres canaux (ex : magasin central) sont donc mises à disposition différemment selon les règles de l'établissement concerné. À l'HRC, par exemple, une Directive institutionnelle relative à la manipulation de produits chimiques encadre l'utilisation de ces produits et un cadastre des produits chimiques achetés, utilisés et stockés à l'HRC est établi. Dans ce contexte, cet établissement a aussi institué un Comité sur la gestion des risque chimiques, au sein duquel la PHEL est représentée.

Les fiches de sécurités des produits chimiques délivrés par la PHEL sont disponibles sur le site internet de la PHEL (www.phel.ch > Informations médicaments > Fiches de sécurité > PHEL - Fiches de sécurité



Home

Fiches de sécurité

- Acétone
- Acide acétique
- Aroma délivrance
- Aroma dilatation (HE lavande vraie , HE petit grain bigarade , HE sauge sclarée , HE ylang-ylang)
- Aroma épisotomie (HE lavande vraie , HE lentisque pistachier , HE ciste , HE geranium rosat , HE tea tree)
- Aroma massage col TV (HE lavande vraie , HE petit grain bigarade , HE sauge sclarée, HE ylang-ylang , HE thym linalol)
- Aroma pendant le travail (HE cannelle de ceylan , HE epinette noire , HE Geranium rosat , HE girofle , HE lavande vraie, HE monarde , HE palmarosa , HE sauge sclarée , HE verveine odorante)
- Aromasan Lavande vraie
- Benjoin teinture
- Benzine médicinale
- Castellani solution (acétone , acide ascorbique , alcool de bouche , chlorocresol , resorcinol)
- Chlorhexidine 2% alcoolique coloré
- Chlorhexidine 2% alcoolique incolore
- Ethanol
- Ether
- Skinman foam
- Skinman soft protect
- Skinman soft protect FF
- Sterillium Gel
- Sterillium Med
- Valériane teinture

Sources :

(1) Organe commun de notification des produits chimiques, Fiche de données de sécurité (FDS), OFSP, 2023, https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/fr/home/themen/pflicht-hersteller/selbstkontrolle/sicherheitsdatenblatt-sdb.html (consulté le 26.03.2025)

(2) Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim), https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/366/fr (consulté le 26.03.2025)